Territorio de la Palabra
REVISTA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA · UAGRM
SANTA CRUZ DE LA SIERRA · BOLIVIA

Vol. 1, N.° 1 (2026) · pp. 41–54
CC BY-NC 4.0

ARTÍCULO METODOLÓGICO · DOCENTES INVESTIGADORES

Método comparativo de enfoques psicoterapéuticos basado en experiencias vivenciales grupales: Psicodrama y Psicoterapia Positiva

A comparative method for psychotherapeutic approaches based on group experiential practices: Psychodrama and Positive Psychotherapy

Teresa Baldiviezo Álvarez[1*]

[1] Carrera de Psicología, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
* Correspondencia: teresabaldiviezo@uagrm.edu.bo

RESUMEN

Objetivo. Formular y fundamentar un método comparativo para enfoques psicoterapéuticos —el Psicodrama y la Psicoterapia Positiva— basado en experiencias vivenciales grupales. Método. Estudio cualitativo de orientación fenomenológica y comparativa, sustentado en el enfoque epistemológico introspectivo-vivencial. La fase documental examinó los antecedentes históricos, los fundamentos epistemológicos y teóricos, los recursos metodológicos y los conceptos de ambos enfoques. La fase vivencial sistematizó experiencias de talleres grupales desarrollados en programas de formación de posgrado en psicoterapia y en la práctica clínica, registradas mediante notas de campo, protocolos de sesión y registros reflexivos de la investigadora. La fase de análisis aplicó nueve criterios de comparación organizados en tres etapas: experiencias vivenciales, alianza terapéutica múltiple y proceso psicoterapéutico. Resultados. Se identificaron convergencias en la centralidad del encuentro terapéutico, el contacto interpersonal, la experiencia grupal y la transformación subjetiva del paciente, y divergencias en las bases epistemológicas, los recursos metodológicos y las formas de intervención de cada enfoque. Conclusiones. El método comparativo propuesto se presenta como una herramienta cualitativa para el análisis sistemático de enfoques psicoterapéuticos, sin establecer jerarquías entre ellos, con utilidad potencial para la formación, la supervisión y la investigación clínica. No constituye una evaluación empírica de la eficacia de los enfoques comparados.

Palabras clave: psicodrama; psicoterapia positiva; método comparado; alianza terapéutica; psicoterapia de grupo

ABSTRACT

Objective. To formulate and substantiate a comparative method for psychotherapeutic approaches—Psychodrama and Positive Psychotherapy—based on group experiential practices. Method. Qualitative study with a phenomenological and comparative orientation, grounded in the introspective-experiential epistemological approach. The documentary phase examined the historical background, epistemological and theoretical foundations, methodological resources, and core concepts of both approaches. The experiential phase systematized experiences from group workshops conducted in graduate psychotherapy training programs and in clinical practice, recorded through field notes, session protocols, and the researcher's reflective records. The analysis phase applied nine comparison criteria organized in three stages: experiential practices, multiple therapeutic alliance, and psychotherapeutic process. Results. Convergences were identified in the centrality of the therapeutic encounter, interpersonal contact, group experience, and the patient's subjective transformation, and divergences in the epistemological bases, methodological resources, and forms of intervention of each approach. Conclusions. The proposed comparative method is presented as a qualitative tool for the systematic analysis of psychotherapeutic approaches, without establishing hierarchies between them, with potential usefulness for training, supervision, and clinical research. It is not an empirical evaluation of the efficacy of the approaches compared.

Keywords: psychodrama; positive psychotherapy; comparative method; therapeutic alliance; group psychotherapy

RECIBIDO
25 de mayo de 2026

ACEPTADO
2 de octubre de 2026

PUBLICADO
30 de noviembre de 2026

CÓMO CITAR (APA 7)
Baldiviezo Álvarez, T. (2026). Método comparativo de enfoques psicoterapéuticos basado en experiencias vivenciales grupales: Psicodrama y Psicoterapia Positiva. *Ñe Renda. Territorio de la Palabra, 1*(1), 41–54.

INTRODUCCIÓN

La investigación en psicología y el ejercicio psicoterapéutico profesional exigen herramientas que permitan objetivar y estructurar la práctica clínica sin desvirtuar los procesos de subjetivación que le son constitutivos. En los programas de formación profesional de modalidad presencial, las experiencias vivenciales constituyen un componente central que sostiene tanto la formación técnica como la formación personal del terapeuta, y operan como principio organizador del conocimiento experiencial que se construye en los espacios de formación y en la práctica terapéutica (Baldiviezo Álvarez, 2018). En los enfoques psicoterapéuticos grupales, las experiencias subjetivas, relacionales y vivenciales adquieren un papel central en la construcción del conocimiento clínico, y las metodologías cualitativas de orientación fenomenológica e introspectivo-vivencial permiten aproximarse a procesos terapéuticos complejos, considerando la experiencia humana como fuente válida de conocimiento (Padrón, 2001).

En la docencia universitaria y la práctica clínica, la transmisión de la metodología de la investigación enfrenta un desafío singular: requiere una transposición didáctica que contemple no solo el "conocer" teórico, sino el "saber hacer" práctico, es decir, aprender a investigar investigando (Wainerman y Sautu, 2011). Bajo esta premisa, el investigador o el docente no es un mero ejecutor de prescripciones, sino que realiza una construcción metodológica propia (Frigerio y Diker, 2005).

Pese al desarrollo de múltiples corrientes psicoterapéuticas, el entorno académico carece con frecuencia de metodologías sistemáticas que permitan comparar las estructuras internas, las epistemologías y las técnicas de intervención de dichos enfoques en formatos grupales (Caballero et al., 2016). Esta carencia limita la formación profesional, la supervisión y la investigación experiencial en psicología clínica. La comparación entre enfoques no busca establecer jerarquías de calidad, sino ofrecer indicadores descriptivos que permitan conocerlos mejor y facilitar su comprensión para la formación y el ejercicio profesional (Baldiviezo Álvarez, 2018).

El presente artículo expone el diseño de un método comparativo aplicado a dos corrientes de relevancia contemporánea: el Psicodrama y la Psicoterapia Positiva. El Psicodrama, desarrollado por Jacob Levy Moreno, utiliza la dramatización, la espontaneidad y el encuentro terapéutico como ejes del proceso clínico (Moreno, 1975). La Psicoterapia Positiva, creada por Nossrat Peseschkian, enfatiza los recursos personales, las capacidades de afrontamiento y la comprensión transcultural de los conflictos humanos (Peseschkian, 1977). Ambos enfoques, aunque difieren en sus bases epistemológicas y sus recursos metodológicos, comparten el interés por la experiencia subjetiva, la interacción interpersonal y el proceso grupal como vías de transformación clínica.

El problema de investigación se centra en cómo estructurar una matriz de comparación metodológica y epistemológica que unifique criterios descriptivos sin alterar los supuestos ontológicos de cada escuela. La finalidad del estudio es proponer una metodología de investigación comparativa entre ambos enfoques, basada en experiencias vivenciales grupales, que ofrezca a profesionales e investigadores un modelo transparente y verificable para el análisis de la intervención psicoterapéutica grupal. El estudio no busca integrar ambos modelos ni jerarquizarlos, sino identificar convergencias, divergencias y posibilidades metodológicas derivadas de su comparación. Se guía por tres preguntas: (a) ¿qué criterios descriptivos permiten comparar el Psicodrama y la Psicoterapia Positiva sin alterar sus supuestos ontológicos y epistemológicos?; (b) ¿qué convergencias y divergencias emergen entre ambos enfoques a partir del análisis de experiencias vivenciales grupales?, y (c) ¿qué aportes ofrece el método propuesto a la formación profesional, la supervisión psicoterapéutica y la investigación clínica cualitativa?

Fundamentación epistemológica

El estudio se sustenta en el enfoque epistemológico introspectivo-vivencial desarrollado por Padrón (1994, 1998, 2001), según el cual el conocimiento científico puede construirse a partir de experiencias subjetivas, procesos de interpretación y vivencias humanas compartidas. Este enfoque privilegia la comprensión de significados, experiencias internas y simbolismos socioculturales mediante la observación participante, la convivencia, la interpretación hermenéutica y el consenso intersubjetivo (Camacho y Marcano, 2003). A diferencia del positivismo, que aspira a la objetividad mediante la separación entre sujeto y objeto, reconoce que el investigador forma parte del fenómeno que estudia y que su experiencia subjetiva constituye una fuente legítima de datos (Padrón, 2001). Esta premisa resulta pertinente en psicoterapia, donde la relación terapéutica, la contratransferencia y la implicación personal del clínico son dimensiones constitutivas del proceso de cambio (Gendlin, 1970; Riveros, 2000), y se inscribe en el giro que, desde mediados del siglo XX, ha reivindicado el valor del conocimiento experiencial frente a las pretensiones de objetividad absoluta (Denzin y Lincoln, 1994; Pérez, 2001).

En consecuencia, la investigación adopta un enfoque fenomenológico orientado a la comprensión de la experiencia vivida, en la línea de la fenomenología husserliana, que propone el retorno "a las cosas mismas", es decir, la descripción de la experiencia tal como se presenta a la conciencia, suspendiendo los juicios teóricos previos (Husserl, 1962). En este estudio, la fenomenología permite aproximarse a la experiencia de los participantes en dispositivos grupales sin reducirla a categorías preestablecidas. Para Rogers (1972), la experiencia subjetiva es el fundamento de todo conocimiento significativo, pues solo aquello que es vivido y sentido por la persona adquiere relevancia para su proceso de cambio.

El concepto de *experiencing* propuesto por Gendlin (1970) es clave para la dimensión vivencial de la propuesta. Gendlin lo define como un proceso vivido, sentido corporalmente y experimentado en interacción con el entorno: un flujo continuo de sensaciones y significados que precede a la conceptualización y constituye la base del cambio terapéutico (Riveros, 2000). A diferencia de las emociones puntuales o de los pensamientos explícitos, el *experiencing* es un proceso prerreflexivo y corporalmente anclado, accesible mediante la atención a la sensación sentida (*felt sense*).

La adscripción al enfoque introspectivo-vivencial se inscribe en la clasificación de metodologías de investigación en psicología de Montero y León (2002) y de León y Montero (2003), que distinguen el enfoque cualitativo de origen fenomenológico, hermenéutico o constructivista del enfoque cuantitativo. Las metodologías cualitativas comprenden tradiciones diversas —fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, investigación acción, análisis narrativo—, cuya elección depende

del objeto, los objetivos y la posición epistemológica del investigador. En psicoterapia, la investigación cualitativa resulta adecuada para explorar procesos subjetivos que no se reducen a variables medibles, comprender la experiencia de los participantes desde su perspectiva y captar la singularidad de los procesos terapéuticos (Denzin y Lincoln, 1994; Martínez, 1996; Pérez, 2001).

El método comparado, por su parte, es una tradición con raíces en la educación comparada (Bereday, 1968; García Garrido, 1996; Hilker, 1964; Raventós, 1983; Velloso y Pedró, 1991) que ha sido incorporada al análisis de enfoques y dispositivos clínicos (Caballero et al., 2016; Martínez Usarralde, 2003). No consiste en la yuxtaposición de descripciones, sino en la construcción de criterios explícitos que permitan identificar convergencias, divergencias y especificidades sin reducir los enfoques a un denominador común que desvirtúe sus supuestos ontológicos (Caballero et al., 2016; Velloso y Pedró, 1991).

En síntesis, la fundamentación del estudio se articula en cuatro ejes: el enfoque introspectivo-vivencial como marco epistemológico general (Padrón, 1994, 1998, 2001); la fenomenología como perspectiva orientada a la experiencia vivida (Husserl, 1962; Rogers, 1972); el *experiencing* como categoría para acceder a la dimensión corporal y prerreflexiva de la experiencia terapéutica (Gendlin, 1970; Riveros, 2000), y el método comparado como estrategia de análisis sistemático (Bereday, 1968; Caballero et al., 2016; Velloso y Pedró, 1991).

MÉTODO

Diseño

Se trata de un estudio cualitativo, de orientación fenomenológica y comparativa, basado en experiencias vivenciales desarrolladas en contextos de psicoterapia grupal. El objeto de estudio fue la construcción de una metodología comparativa entre el Psicodrama y la Psicoterapia Positiva. El carácter comparativo se sustenta en el método comparado (Bereday, 1968; García Garrido, 1996; Hilker, 1964; Raventós, 1983; Velloso y Pedró, 1991), que exige construir criterios explícitos para identificar convergencias y divergencias sin alterar los supuestos ontológicos de cada escuela (Caballero et al., 2016; Martínez Usarralde, 2003).

Participantes y escenario

Las experiencias sistematizadas provienen de talleres grupales de Psicodrama y de Psicoterapia Positiva desarrollados en programas de formación de posgrado —la Maestría en Psicoterapia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Maestría en Psicoterapia Positiva de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz— y en la práctica psicoterapéutica. Los participantes fueron adultos vinculados a esos programas y profesionales en ejercicio clínico. Los grupos estuvieron conformados por entre 8 y 15 participantes, se desarrollaron en modalidad pre-

sencial y tuvieron una duración variable según el dispositivo. La investigadora acumula más de dos décadas de experiencia en la conducción de talleres vivenciales de Psicodrama y en experiencias formativas de Psicoterapia Positiva (Baldiviezo Álvarez, 2018). Dado el carácter cualitativo del estudio, no se buscó representatividad estadística, sino densidad experiencial y pertinencia de los casos.

Fases del método comparativo

La metodología se estructuró en tres fases consecutivas, conforme a los fundamentos del método comparado (Bereday, 1968; García Garrido, 1996; Raventós, 1983; Velloso y Pedró, 1991).

Fase documental

Consistió en la revisión, el análisis y la delimitación de los marcos teóricos y epistemológicos de ambos enfoques, en correspondencia con la fase descriptiva del método comparado (García Garrido, 1996; Raventós, 1983). Se examinaron las bases del Psicodrama —su concepción del encuentro, la espontaneidad y la acción— (Boria, 2001; Moreno, 1975) y de la Psicoterapia Positiva —basada en las capacidades humanas y el balance transcultural— (Peseschkian, 1977; Peseschkian y Remmers, 2013), en seis dimensiones: aspectos históricos, bases epistemológicas, fundamentos teóricos, recursos metodológicos, conceptos fundamentales y psicoterapia grupal.

Fase vivencial

Se centró en el procesamiento de experiencias grupales reales, diseñadas y ejecutadas según las directrices técnicas de cada enfoque, mediante su registro, seguimiento y descripción. Corresponde al nivel vivencial e introspectivo del enfoque epistemológico adoptado (Padrón, 2001) e incorporó el concepto de *experiencing*, entendido como un proceso de interacción incesante entre los sentimientos personales y corporales y los símbolos propios o del medio (Gendlin, 1970; Riveros, 2000). El registro se realizó mediante notas de campo, protocolos de sesión y registros reflexivos elaborados por la investigadora, así como mediante materiales producidos en los talleres —dibujos, narrativas y dramatizaciones registradas en video cuando hubo consentimiento—, que constituyeron el corpus del análisis.

Fase de análisis

Se organizó en tres etapas secuenciales y aplicó nueve criterios de comparación, que actúan como indicadores descriptivos, sin juicios de valor sobre la calidad de un enfoque frente al otro (Baldiviezo Álvarez, 2018; García Garrido, 1996), en concordancia con el criterio de comparación como elemento esencial del método comparado (Raventós, 1983; Velloso y Pedró, 1991). La Tabla 1 presenta las etapas y sus criterios.

Tabla 1
Etapas de análisis y criterios de comparación

Etapa	Criterios de comparación
Primera: análisis de experiencias vivenciales	1. Experiencias vivenciales grupales de Psicoterapia Positiva; 2. Experiencias vivenciales grupales de Psicodrama
Segunda: análisis de la alianza terapéutica múltiple	3. Alianza en relación con el cuerpo; 4. Alianza en relación con el síntoma; 5. Alianza en relación con el contacto entre terapeuta y paciente
Tercera: análisis del proceso psicoterapéutico	6. Fases y etapas de intervención; 7. Encuentro; 8. Resistencia; 9. Catarsis

Nota. Elaboración propia a partir de Baldiviezo Álvarez (2018).

La primera etapa desarrolló un análisis teórico y metodológico de las experiencias vivenciales de ambos enfoques, con el propósito de elevar el nivel experiencial al rango de mediación conceptual (Baldiviezo Álvarez, 2018). La segunda comparó los componentes de la alianza terapéutica múltiple —la relación terapéutica vinculada al cuerpo, al síntoma y al contacto entre terapeuta y paciente—, eje transversal de los procesos de cambio (Bordin, 1994; Horvath y Luborsky, 1993; Watson y Greenberg, 1995). La tercera comparó las fases del proceso psicoterapéutico, el encuentro —inspirado en la filosofía del Yo-Tú de Buber (1984) y central en el Psicodrama (Moreno, 1975)—, la resistencia y la catarsis, que admiten operacionalizaciones diferenciadas en cada enfoque (Peseschkian, 1977; Rosenzweig, 2002).

Análisis de los materiales

El análisis siguió un procedimiento de análisis temático comparativo en cinco momentos: (a) inmersión en los materiales mediante la lectura y relectura de registros, notas de campo y producciones de los talleres; (b) codificación inicial de segmentos significativos en relación con los nueve criterios; (c) organización en matrices comparativas que contrastaron la operacionalización de cada criterio en ambos enfoques; (d) interpretación hermenéutica de los significados emergentes, articulando la experiencia vivencial con los marcos teóricos de cada enfoque, y (e) síntesis comparativa de convergencias, divergencias y aportes del método.

Rigor y reflexividad

Se adoptaron los criterios de rigor propuestos por Martínez (1996) para la investigación en ciencias humanas (Tabla 2) y los de León y Montero (2003) y Montero y León (2002), que enfatizan la coherencia entre el objeto de estudio, el método y los resultados, así como la transparencia del procedimiento. La investigadora, que condujo los talleres analizados, ocupa una doble posición de facilitadora e investigadora; esta implicación se reconoce como constitutiva del enfoque adoptado y

como una fuente de posible sesgo interpretativo que se procuró controlar mediante el registro reflexivo.

Tabla 2

Criterios de rigor y estrategias aplicadas

Criterio	Estrategia aplicada
Credibilidad	Triangulación de fuentes (registros vivenciales, revisión documental y literatura teórica de cada enfoque); uso de registros textuales en el análisis para sustentar las interpretaciones
Transferibilidad	Descripción del contexto de los talleres, los participantes y los dispositivos empleados
Dependencia	Documentación sistemática del proceso de análisis y registro de las decisiones metodológicas
Confirmabilidad	Reflexividad crítica de la investigadora respecto de su implicación en el fenómeno y de sus posicionamientos teóricos

Nota. Elaborado a partir de Martínez (1996).

Consideraciones éticas

Los participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio, el carácter voluntario de su participación y el uso confidencial de la información, y otorgaron su consentimiento informado por escrito para la participación y, cuando correspondió, para el registro audiovisual de las sesiones. Los materiales fueron anonimizados y resguardados de forma segura. Dado que la investigadora conducía los talleres en programas de formación en los que participaban estudiantes, se reconoce una relación asimétrica que exige garantizar que la negativa a participar en el estudio no tuviera consecuencias académicas.

RESULTADOS

Los resultados se presentan según las fases del método comparativo: documental, vivencial y de análisis.

Resultados de la fase documental

La revisión teórica evidenció diferencias epistemológicas sustantivas entre ambos enfoques. El Psicodrama se fundamenta en la espontaneidad, la creatividad, la dramatización y el encuentro terapéutico (Boria, 2001; Moreno, 1975), mientras que la Psicoterapia Positiva enfatiza los recursos personales, las capacidades de afrontamiento y el equilibrio transcultural (Peseschkian, 1977; Peseschkian y Remmers, 2013). Ambos coinciden en reconocer la importancia de la experiencia subjetiva, la interacción interpersonal y el proceso grupal (Rosenzweig, 2002). La revisión de antecedentes identificó aplicaciones del Psicodrama en contextos clínicos, educativos, comunitarios y formativos de diversos países latinoamericanos y europeos (Caballero et al., 2016), y de la Psicoterapia Positiva en contextos trans-

culturales, con énfasis en las capacidades y recursos personales (Peseschkian y Remmers, 2013). La Tabla 3 sintetiza el contraste.

Tabla 3

Matriz de contraste epistemológico y operacional entre ambos enfoques

Criterio de comparación	Psicodrama	Psicoterapia Positiva
Eje epistemológico	Filosofía del momento, la acción, el coinconsciente y la espontaneidad creadora (Moreno, 1975)	Enfoque humanista-transcultural, centrado en las capacidades y en una concepción positiva del ser humano (Peseschkian, 1977)
Dispositivo grupal	Escenario psicodramático: director, protagonista, yo auxiliares y auditorio (Boria, 2001; Moreno, 1975)	Grupo de interacción basado en las capacidades de conocer y de amar y en el modelo de balance (Peseschkian, 1977)
Fases de intervención	Caldeamiento (inespecífico y específico), acción (dramatización) y compartir (eco grupal) (Moreno, 1975)	Observación y distanciamiento, inventario, estimulación situacional, verbalización y ampliación de metas (Peseschkian, 1977)

Nota. Elaboración propia a partir de Moreno (1975), Peseschkian (1977) y Baldiviezo Álvarez (2018).

Resultados de la fase vivencial

Las experiencias grupales permitieron reconocer que el componente vivencial es central en los procesos psicoterapéuticos de ambos enfoques, que favorecen (a) la participación del paciente, (b) la expresión emocional, (c) la interacción grupal, (d) los procesos de autoconocimiento y (e) la construcción de significados subjetivos. Las experiencias vivenciales facilitaron, además, la comprensión de procesos relacionales difíciles de captar con metodologías exclusivamente descriptivas o cuantitativas (Denzin y Lincoln, 1994; Pérez, 2001). El concepto de *experiencing* resultó pertinente para describir la dimensión corporal y subjetiva de estas experiencias (Gendlin, 1970; Riveros, 2000).

Resultados de la fase de análisis

Primera etapa: experiencias vivenciales

La comparación identificó convergencias en la importancia del encuentro terapéutico, la interacción grupal y la construcción experiencial del conocimiento clínico. Las divergencias principales se asociaron a los recursos metodológicos: el Psicodrama utiliza la dramatización, la representación escénica y los roles (Boria, 2001; Moreno, 1975), mientras que la Psicoterapia Positiva privilegia recursos narrativos, reflexivos y transculturales (Peseschkian, 1977).

Segunda etapa: alianza terapéutica múltiple

Ambos enfoques consideran el vínculo terapéutico como condición del cambio clínico (Bordin, 1994; Horvath y Luborsky, 1993; Paivio y Bahr, 1998). En el Psico-

drama, el cuerpo y la dramatización ocupan un lugar central en la construcción de la alianza (Moreno, 1975); en la Psicoterapia Positiva predomina el trabajo interpretativo, reflexivo y relacional (Peseschkian, 1977). Respecto del síntoma, ambos modelos reconocen su valor comunicacional y su función en el proceso terapéutico (Poch y Ávila, 1997). En la operacionalización de la alianza, el Psicodrama emplea el cuerpo y la acción como vías de acceso al núcleo del conflicto mediante técnicas como la inversión de roles o el espejo (Boria, 2001; Moreno, 1975), mientras que la Psicoterapia Positiva recurre a la resignificación del síntoma mediante historias, metáforas y el autoanálisis de las capacidades primarias y secundarias (Peseschkian, 1977; Peseschkian y Remmers, 2013).

Tercera etapa: proceso psicoterapéutico

La comparación identificó semejanzas en las etapas relacionadas con el encuentro, la resistencia y la catarsis. En ambos enfoques, el proceso implica movilización emocional, elaboración subjetiva y transformación relacional, y supone respetar reglas que orientan los actos terapéuticos sin excluir la espontaneidad y la creatividad ni asumir una secuencia lineal y estática (Baldiviezo Álvarez, 2018). Cada modelo organiza, sin embargo, esas etapas mediante recursos técnicos diferenciados (Tabla 4).

Tabla 4

Operacionalización de los criterios clínicos de intervención en ambos enfoques

Fenómeno clínico	Psicodrama	Psicoterapia Positiva
Encuentro (criterio 7)	Tele y copresencia: relación cara a cara e inmediata, en la que los roles se vivencian en el aquí y ahora (Buber, 1984; Moreno, 1975)	Vínculo dialógico transcultural basado en la aceptación del paciente a partir de sus capacidades básicas (Peseschkian, 1977)
Resistencia (criterio 8)	Bloqueo de la espontaneidad o caldeamiento deficiente, manifestado en el cuerpo o en la imposibilidad de accionar (Moreno, 1975)	Esfuerzo adaptativo del paciente aferrado a conceptos tradicionales inconscientes (Peseschkian, 1977; Peseschkian y Remmers, 2013)
Catarsis (criterio 9)	Catarsis de integración y de acción; liberación emocional compartida en el grupo (Moreno, 1975; Rosenzweig, 2002)	Proceso paulatino de toma de conciencia, *insight* cognitivo-afectivo y reequilibrio en el modelo de balance (Peseschkian, 1977)

Nota. Elaboración propia a partir de Buber (1984), Moreno (1975), Peseschkian (1977) y Rosenzweig (2002).

Síntesis

Los resultados de las tres fases pueden sintetizarse en tres hallazgos. En cuanto a las convergencias, ambos enfoques comparten la centralidad del encuentro terapéutico, la relevancia del contacto interpersonal y la experiencia grupal como vías de transformación subjetiva, y la alianza terapéutica aparece como eje transversal. En cuanto a las divergencias, estas se concentran en las bases epistemoló-

gicas (filosofía de la acción y la espontaneidad frente a enfoque humanista-transcultural), los recursos metodológicos (dramatización y roles frente a narrativas y reflexión) y las formas de intervención (acción corporal frente a trabajo interpretativo). En cuanto al método, la propuesta permitió operacionalizar criterios descriptivos para la comparación sistemática de ambos enfoques sin reducir sus especificidades ni jerarquizarlos.

DISCUSIÓN

El estudio se propuso formular y fundamentar un método comparativo para enfoques psicoterapéuticos basado en experiencias vivenciales grupales. Los hallazgos permiten discutir tres dimensiones: la pertinencia del enfoque introspectivo-vivencial para la investigación en psicoterapia, las convergencias y divergencias entre ambos enfoques, y los aportes y limitaciones del método propuesto.

Los resultados respaldan la pertinencia del enfoque introspectivo-vivencial (Padrón, 1994, 1998, 2001) para investigaciones cualitativas sobre psicoterapia y procesos grupales. Este enfoque permitió elevar la experiencia vivencial al nivel de mediación conceptual y metodológica (Baldiviezo Álvarez, 2018), reconociendo la experiencia terapéutica como vía para la construcción de conocimiento (Gendlin, 1970; Riveros, 2000), en línea con los criterios de Martínez (1996): basar el procedimiento en observaciones sistemáticas y expresar los resultados mediante una estructura coherente. La adopción de este enfoque implica, sin embargo, una posición epistemológica explícita y no neutral: el investigador forma parte del fenómeno que estudia (Padrón, 2001). Esa implicación puede ser una fortaleza en psicoterapia, donde la relación terapéutica y la implicación del clínico son constitutivas del cambio (Gendlin, 1970; Riveros, 2000), pero exige una reflexividad crítica permanente para distinguir entre la experiencia subjetiva de la investigadora y los hallazgos que se desprenden del análisis de los materiales.

Las convergencias identificadas —centralidad del encuentro, del contacto interpersonal y de la experiencia grupal— y el papel transversal de la alianza terapéutica son consistentes con la tesis de los factores comunes en psicoterapia (Rosenzweig, 2002) y con la literatura sobre la alianza (Bordin, 1994; Horvath y Luborsky, 1993; Watson y Greenberg, 1995). Las divergencias —bases epistemológicas, recursos metodológicos y formas de intervención— no constituyen jerarquías de calidad, sino especificidades que deben respetarse en toda comparación (Caballero et al., 2016; Velloso y Pedró, 1991). Un hallazgo relevante es que ambos enfoques comparten una concepción no lineal del proceso terapéutico, que respeta la espontaneidad y la creatividad sin renunciar a una estructura que orienta los actos terapéuticos (Baldiviezo Álvarez, 2018); esta convergencia sugiere un núcleo común en la concepción del cambio que podría servir de base para el diálogo entre enfoques en la psicoterapia grupal.

Implicaciones teóricas y prácticas

En el plano teórico, el estudio propone una forma de trasladar el método comparado, de tradición pedagógica, al análisis de enfoques psicoterapéuticos, mediante criterios explícitos —experiencias vivenciales, alianza terapéutica múltiple y proceso psicoterapéutico— que pueden aplicarse a otros enfoques (Caballero et al., 2016; Martínez Usarralde, 2003). En el plano práctico, ofrece a docentes, estudiantes y supervisores una guía estructurada para examinar la práctica clínica con rigor epistemológico y favorecer la transposición didáctica del "saber hacer" en investigación psicológica (Frigerio y Diker, 2005; Wainerman y Sautu, 2011), en un campo donde la investigación cualitativa ha estado históricamente subrepresentada frente a los diseños cuantitativos (Denzin y Lincoln, 1994; Pérez, 2001). Su utilidad formativa debe, no obstante, evaluarse empíricamente.

Limitaciones

El estudio presenta limitaciones que deben reconocerse. Primera, no es un estudio empírico sobre los efectos de las modalidades comparadas: compara dos enfoques a partir de experiencias vivenciales para actualizar la metodología psicoterapéutica grupal como herramienta de trabajo (Baldiviezo Álvarez, 2018). Segunda, el artículo no informa el número de talleres ni de participantes analizados, ni reproduce fragmentos de los registros que sustentan las interpretaciones, lo que limita la posibilidad de que el lector valore la credibilidad de los hallazgos. Tercera, la implicación de la investigadora como facilitadora de los talleres, aunque constitutiva del enfoque introspectivo-vivencial, no elimina el riesgo de sesgo interpretativo, y el análisis no incluyó contraste con otros codificadores. Cuarta, el carácter situado de las experiencias impide extrapolar los resultados a otros contextos sin la debida cautela. Por último, el estudio no pretende la integración del Psicodrama y la Psicoterapia Positiva: sus resultados deben entenderse como convergencias o coincidencias, no como integraciones.

Líneas futuras

Sería pertinente aplicar el método a otros enfoques —por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, sistémica o humanista— para evaluar su capacidad de generar indicadores descriptivos pertinentes; desarrollar estudios con diseños mixtos que evalúen los efectos de los dispositivos grupales de cada enfoque en poblaciones específicas, y explorar las implicaciones del método para la supervisión psicoterapéutica, incorporando el contraste entre varios analistas.

CONCLUSIONES

El estudio permitió elaborar una propuesta de metodología comparativa entre enfoques psicoterapéuticos basada en experiencias vivenciales grupales, organizada en una fase documental, una vivencial y una de análisis con nueve criterios de comparación.

La aplicación del método al Psicodrama y a la Psicoterapia Positiva permitió identificar convergencias en la centralidad del encuentro terapéutico, el contacto interpersonal y la experiencia grupal, y divergencias en las bases epistemológicas, los recursos metodológicos y las formas de intervención, sin reducir las especificidades de cada enfoque ni establecer jerarquías entre ellos.

La alianza terapéutica múltiple —en relación con el cuerpo, el síntoma y el contacto terapéutico— emergió como uno de los principales criterios comparativos, en consonancia con la literatura sobre factores comunes, lo que sugiere que la alianza constituye un eje que trasciende las diferencias entre enfoques.

El enfoque introspectivo-vivencial se mostró pertinente para el análisis de procesos terapéuticos subjetivos, relacionales y grupales, a condición de explicitar la implicación de la investigadora y de documentar los materiales que sustentan las interpretaciones.

El estudio no constituye una validación empírica de los efectos de las modalidades comparadas, sino una propuesta metodológica que puede orientar la formación, la supervisión y la investigación cualitativa en psicoterapia, y cuya utilidad deberá contrastarse en futuras aplicaciones a otros enfoques.

REFERENCIAS

Bereday, G. Z. F. (1968). *El método comparativo en pedagogía*. Herder.

Bordin, E. S. (1994). Theory and research on the therapeutic working alliance: New directions. En A. O. Horvath y L. S. Greenberg (Eds.), *The working alliance: Theory, research, and practice* (pp. 13–37). Wiley.

Buber, M. (1984). *Yo y tú*. Nueva Visión.

Denzin, N. K., y Lincoln, Y. S. (Eds.). (1994). *Handbook of qualitative research*. SAGE.

Frigerio, G., y Diker, G. (Comps.). (2005). *Educar: Ese acto político*. Del Estante.

García Garrido, J. L. (1996). *Fundamentos de educación comparada* (3.ª ed.). Dykinson.

Gendlin, E. T. (1970). A theory of personality change. En J. T. Hart y T. M. Tomlinson (Eds.), *New directions in client-centered therapy* (pp. 129–173). Houghton Mifflin.

Hilker, F. (1964). *La pédagogie comparée: Introduction à son histoire, sa théorie et sa pratique*.

Horvath, A. O., y Luborsky, L. (1993). The role of the therapeutic alliance in psychotherapy. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, *61*(4), 561–573. https://doi.org/10.1037/0022-006X.61.4.561

Husserl, E. (1962). *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica* (J. Gaos, Trad.; 2.ª ed.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1913)

León, O. G., y Montero, I. (2003). *Métodos de investigación en psicología y educación* (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Martínez, M. (1996). *Comportamiento humano: Nuevos métodos de investigación*

Martínez Usarralde, M. J. (2003). *Educación comparada: Nuevos retos, renovados desafíos*. La Muralla.

Montero, I., y León, O. G. (2002). Clasificación y descripción de las metodologías de investigación en Psicología. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, *2*(3), 503–508.

Moreno, J. L. (1975). *Psicodrama*.

Paivio, S. C., y Bahr, L. M. (1998). Interpersonal problems, working alliance, and outcome in short-term experiential therapy. *Psychotherapy Research*, *8*

Peseschkian, H., y Remmers, A. (2013). *Positive Psychotherapie*.

Peseschkian, N. (1977). *Positive Psychotherapie: Theorie und Praxis einer neuen Methode*.

Rogers, C. R. (1972). *El proceso de convertirse en persona*

Rosenzweig, S. (2002). Some implicit common factors in diverse methods of psychotherapy. *Journal of Psychotherapy Integration*, *12*(1), 5–9. https://doi.org/10.1037/1053-0479.12.1.5 (Obra original publicada en 1936)

Wainerman, C., y Sautu, R. (Comps.). (2011). *La trastienda de la investigación* (4.ª ed.). Manantial.

Watson, J. C., y Greenberg, L. S. (1995). Alliance ruptures and repairs in experiential therapy. *In Session: Psychotherapy in Practice*, *1*

Este artículo se publica en acceso abierto bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).